

// A BASE QUE NINGUÉM TREINA

O TORNOZELO ESQUECIDO

A articulação que sustenta cada passo — e decide a saúde dos seus joelhos, quadris e coluna. Acorde a sua fundação.

GUSTAVO CORREIA VIEIRA

PREPARAÇÃO FÍSICA & PERFORMANCE

1ª Edição · 2026

Fontes A1/A2 · Qualis

SUMÁRIO

00	A BASE QUE NINGUÉM TREINA	03
	Por que o tornozelo decide tanta coisa.	
01	A FUNDAÇÃO DO MOVIMENTO	04
	Tudo o que você faz em pé começa aqui.	
02	A CADEIA CINÉTICA: O PROBLEMA SOBE	05
	Tornozelo travado vira dor no joelho e nas costas.	
03	DORSIFLEXÃO: O NÚMERO-CHAVE	06
	A amplitude que destrava o agachamento.	
04	A ENTORSE QUE VOLTA	07
	A lesão nº1 — e por que ela recidiva.	
05	EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO	08
	Os sensores que protegem o seu tornozelo.	
★	TESTE, MOBILIZE, ESTABILIZE, EQUILIBRE	10
	O programa completo do tornozelo.	
06	APLICAÇÃO + ERROS	15
	Corrida, agachamento, esporte — e o que evitar.	
→	SUA AVALIAÇÃO DE TORNOZELO	17
	Como eu posso blindar a sua base.	

// INTRODUÇÃO

A BASE QUE NINGUÉM TREINA

Você treina peito, perna, abdômen. Mas e a articulação que sustenta tudo isso de pé? O tornozelo é a fundação esquecida do corpo.

Sou o Gustavo, preparador físico. Pense numa casa: não importa quão bonitas sejam as paredes — se a fundação está torta, rachaduras aparecem em todo lugar. Com o corpo é igual. O tornozelo é o primeiro contato com o chão a cada passo, salto e agachamento; é por ele que a força sobe e a estabilidade se organiza. Quando ele está rígido ou instável, o problema **não fica ali**: ele viaja para cima, em forma de dor no joelho, no quadril e até na lombar.

E ainda assim quase ninguém treina o tornozelo. Ele só vira assunto depois da primeira entorse — quando já virou um problema crônico que volta sempre. Este guia muda essa lógica: você vai entender por que o tornozelo decide tanta coisa, testar o seu, e receber um programa completo de mobilidade, força, estabilidade e equilíbrio. Tudo com base em evidência de alto nível (**A1/A2 no Qualis**).



FIG. 00 · EQUILÍBRIO COMEÇA NO TORNOZELO

A VIRADA DE CHAVE

Pare de tratar o tornozelo como detalhe. Ele é a **fundação** — e cuidar dele é o investimento de maior retorno (e mais ignorado) para joelhos, quadris e desempenho.

// CAPÍTULO 01

A FUNDAÇÃO DO MOVIMENTO

Todo movimento em pé nasce no contato do pé com o chão. O tornozelo é onde a força entra e a estabilidade se organiza.

A cada passo de corrida, o tornozelo absorve **várias vezes** o seu peso corporal e devolve essa energia para o próximo passo. No agachamento, é ele que permite o joelho avançar para você descer fundo. Num corte ou mudança de direção, é ele que estabiliza para você não torcer. Ele é, ao mesmo tempo, **móvel** (precisa de amplitude) e **estável** (precisa de controle) — uma combinação rara e preciosa.

1º**CONTATO**

A primeira articulação a tocar o chão e receber a carga.

xP**CARGA**

Suporta múltiplos do peso corporal a cada passada e salto.

M+E**MÓVEL E ESTÁVEL**

Precisa de amplitude para agachar e controle para não torcer.

Quando essa fundação trabalha bem, a força sobe limpa pela perna e o resto do corpo se move com eficiência. Quando ela falha — por rigidez ou instabilidade —, os andares de cima improvisam: o joelho desaba para dentro, o quadril compensa, a lombar paga a conta. É por isso que tantos problemas "lá em cima" começam, na verdade, lá embaixo.

A GRANDE SACADA

O tornozelo não é uma peça isolada — é a **base de uma cadeia**. Cuidar dele é cuidar de tudo o que está acima. É o próximo capítulo.

// CAPÍTULO 02

A CADEIA CINÉTICA: O PROBLEMA **SOBE**

O corpo é uma corrente de articulações conectadas. Trave um elo na base e os elos de cima são obrigados a compensar.

Esse é o conceito de **cadeia cinética**: o que acontece em uma articulação afeta as vizinhas. E como o tornozelo está na base, qualquer limitação dele se propaga **para cima**. O exemplo mais estudado: a falta de dorsiflexão (tornozelo "preso") está associada a maior **valgo de joelho** — aquele desabamento do joelho para dentro no agachamento e na aterrissagem, que é fator de risco para lesões de joelho.

COMO A RESTRIÇÃO VIAJA PELA CADEIA

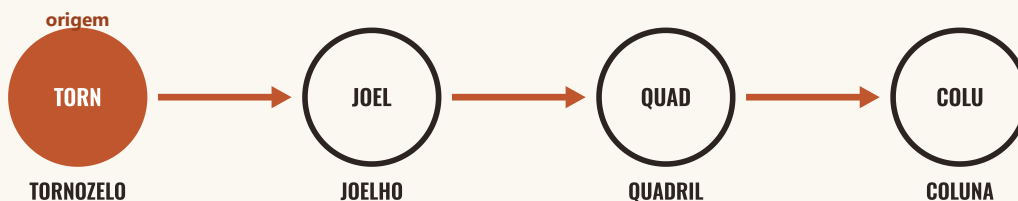


FIG. 02 · um tornozelo travado força o joelho a desabar (valgo), o quadril a compensar e a lombar a absorver o que sobra. A origem do problema costuma estar embaixo dele.

Por isso é tão comum tratar o joelho que dói, ou a lombar que reclama, sem nunca olhar para o tornozelo — e o problema voltar. Em muitos casos, a peça que precisa de atenção está um ou dois andares **abaixo** de onde dói.

NA PRÁTICA

Joelho que desaba no agachamento, dor na frente do joelho ao correr, dificuldade de descer fundo: vale **investigar o tornozelo** antes de culpar só o joelho. Muitas vezes a solução está na fundação.

A BOA NOTÍCIA

Como o tornozelo é a base, mexer nele costuma dar um retorno desproporcional: destravar a dorsiflexão e estabilizar o tornozelo frequentemente **alivia dores de joelho** que resistiam a tratamentos focados só no joelho.

// CAPÍTULO 03

DORSIFLEXÃO: O NÚMERO-CHAVE

Se existe uma medida que resume a saúde do tornozelo, é a dorsiflexão: o quanto o joelho avança sobre o pé com o calcanhar no chão.

Dorsiflexão é o movimento de aproximar o peito do pé da canela — exatamente o que acontece quando você agacha fundo ou desce uma ladeira. Sem ela, o corpo improvisa: levanta o calcanhar, joga o tronco à frente ou deixa o joelho cair para dentro. Por isso a dorsiflexão limitada aparece ligada a problemas no joelho e a um agachamento de qualidade ruim.

DORSIFLEXÃO E O TESTE DO JOELHO À PAREDE

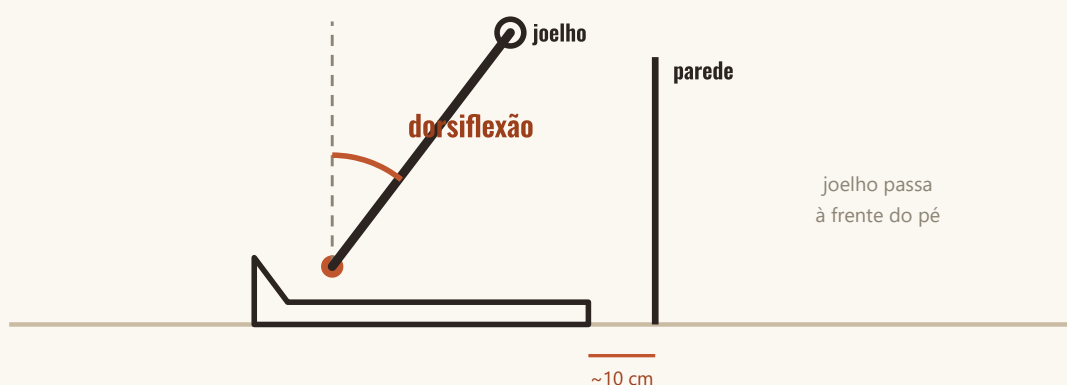


FIG. 03 · de joelho no chão, avance o joelho em direção à parede com o calcanhar fixo. Tocar a parede com o pé a ~10 cm de distância indica boa dorsiflexão.

TESTE RÁPIDO (JOELHO À PAREDE)

Pé a ~10 cm da parede, calcanhar no chão: o joelho toca a parede sem levantar o calcanhar? **Bom.** Não toca, ou só tocando bem mais perto? Dorsiflexão limitada — alvo das próximas páginas. Compare os dois lados: assimetria também conta.

POR QUE IMPORTA TANTO

Ganhar dorsiflexão melhora a profundidade e a segurança do agachamento, reduz o valgo de joelho e melhora a corrida em descida. É um dos ajustes de **maior retorno** no corpo todo.

// CAPÍTULO 04

A ENTORSE QUE VOLTA

A entorse de tornozelo é tratada como "bobagem que passa". Os números mostram o contrário: ela é a lesão nº1 do esporte — e a que mais volta.

A entorse lateral (aquele "virar o pé" para fora) é a lesão musculoesquelética mais comum no esporte e responde por cerca de **85% das lesões de tornozelo**. O problema não é a primeira entorse — é o que vem depois: as taxas de **recidiva chegam a 70%**, e cerca de **40% das pessoas** desenvolvem instabilidade crônica do tornozelo (CAI) após a primeira entorse.

A ENTORSE EM NÚMEROS

85%

das lesões de tornozelo
são entorse lateral

até 70%

de recidiva quando não
se reabilita

~40%

desenvolvem instabilidade
crônica

FIG. 04 · a maioria das entorses não é tratada de verdade — e por isso volta. Recidiva e instabilidade crônica são a regra, não a exceção, quando se ignora a reabilitação.

Por que isso acontece? Porque quase ninguém reabilita a entorse. A pessoa espera o inchaço baixar, a dor passar, e volta a treinar — mas o tornozelo ficou com a estabilidade e os "sensores" prejudicados. Resultado: ele torce de novo, mais fácil, criando um ciclo vicioso de entorses.

O ERRO QUE CRIA O CICLO

"Já parou de doer, está curado." **Errado.** Parar de doer não é o mesmo que recuperar força, estabilidade e equilíbrio. Pular essa parte é o que transforma uma entorse em um problema para a vida toda.

O CICLO VICIOSO

Entorse → para de doer → volta sem reabilitar → sensores e estabilidade fracos → **torce de novo, mais fácil**. Cada repetição enfraquece ainda mais a base. A única forma de quebrar o ciclo é reabilitar de verdade: força, estabilidade e equilíbrio.

// CAPÍTULO 05

EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO

O tornozelo é cheio de sensores que dizem ao cérebro onde o seu pé está. Treiná-los é o que evita a próxima torção.

Propriocepção é o "sexto sentido" do corpo: a capacidade de saber a posição da articulação sem olhar. No tornozelo, esses sensores disparam ajustes em milésimos de segundo para te impedir de torcer quando você pisa torto. Depois de uma entorse — ou por puro sedentarismo — esses sensores ficam "lentos", e é aí que o tornozelo falha.

A boa notícia: dá para treinar isso, e funciona muito bem. Uma meta-análise mostrou que o treino proprioceptivo (equilíbrio) **reduz em 36% o risco** de novas entorses em quem já teve uma (RR 0,64) — um dos melhores retornos de qualquer estratégia de prevenção.

-36%

RISCO DE RECIDIVA

Com treino de equilíbrio em quem já teve entorse (RR 0,64).

ms

REFLEXO

Sensores que corrigem a pisada em milésimos de segundo.

1 pé

O TREINO

Fica em um pé só — e progride para olhos fechados e superfícies instáveis.

O MELHOR DE TUDO

Treino de equilíbrio é simples, rápido e cabe em qualquer lugar: **basta ficar em um pé só**, com progressões. Poucos minutos por dia recalibram os sensores e blindam o seu tornozelo.

// MÃOS À OBRA

ACORDE O SEU TORNOZELO

Chega de teoria. Agora o protocolo completo: teste o seu tornozelo, devolva a mobilidade, construa força e estabilidade, e recalibre o equilíbrio. Quatro frentes que, juntas, blindam a sua fundação.

01

TESTE

Saiba onde você está hoje.

02

MOBILIZE

Devolva a dorsiflexão.

03

ESTABILIZE

Força e controle.

04

EQUILIBRE

Recalibre os sensores.

// 01 · TESTE

TESTE O SEU TORNOZELO

Três testes caseiros, 5 minutos, sem equipamento. Anote os dois lados — assimetria é informação valiosa.

- 1 Dorsiflexão (joelho à parede).** De joelho no chão, pé a ~10 cm da parede, calcanhar fixo. O joelho toca a parede? Meça a distância máxima em que ainda toca, nos dois pés. **Alvo: ~10 cm.**
- 2 Equilíbrio em um pé (olhos abertos → fechados).** Fique em um pé só. Tranquilo de olhos abertos? Feche os olhos. **Alvo: ~30 s de olhos abertos e ~10 s de olhos fechados**, sem se segurar.
- 3 Salto e aterrissagem em um pé.** Dê um pequeno salto à frente e aterrisse em um pé só, segurando firme por 2–3 s. Wobbla muito, gira o tornozelo ou precisa dar um passo? Sinal de instabilidade.

 ANOTE OS SEUS NÚMEROS

Joelho à parede: D ____ cm · E ____ cm | Equilíbrio olhos fechados: D ____ s · E ____ s |
Aterrissagem 1 pé: firme? D ☐ E ☐

COMO INTERPRETAR

Dificuldade na dorsiflexão? Foque em **mobilidade** (pág. 11). Cambaleia no equilíbrio? Foque em **propriocepção** (pág. 13). Aterrissagem instável? Precisa de **força e estabilidade** (pág. 12). Diferença grande entre os lados merece atenção redobrada.

// 02 · MOBILIZE

DEVOLVA A DORSIFLEXÃO

Recuperar amplitude de tornozelo é rápido quando o estímulo é o certo: movimento na amplitude final + um pouco de carga.



FIG. 11 · O AGACHAMENTO PROFUNDO É MOBILIDADE CARREGADA

- 1 **Mobilização joelho à parede.** Empurre o joelho à frente do pé (calcanhar fixo) buscando a parede, com leve pressão. 2–3 × 10 oscilações por lado.
- 2 **Agachamento profundo segurando o fundo.** Desça o máximo com calcanhares no chão e segure 20–30 s, "cavando" amplitude. 2–3 séries.
- 3 **Panturrilha com controle excêntrico.** Suba na ponta e desça **bem devagar** (3–4 s) abaixando o calcanhar além do degrau. 3 × 8–10.
- 4 **Alongamento da panturrilha com carga.** Pé na parede ou no step, projete o joelho à frente sustentando o alongamento ativo. 2 × 30 s/lado.

A CHAVE DO RESULTADO

Não é só "alongar passivo". É **levar o tornozelo à amplitude final em movimento e com um pouco de carga** — é isso que faz a dorsiflexão ganhar durar. Faça quase diário e reteste o joelho à parede a cada 2 semanas.

// 03 · ESTABILIZE

FORÇA E CONTROLE

Mobilidade sem força é instabilidade. Um tornozelo forte é um tornozelo que não torce — e que aguenta corrida, salto e mudança de direção.

- 1 Panturrilha em pé e sentado.** Trabalhe os dois músculos da panturrilha (joelho estendido e flexionado). 3 × 10–12, progredindo carga.
- 2 Panturrilha em um pé só.** A versão que de fato desafia: sobe e desce controlado, apoiado em um pé. 3 × 8–10 por lado.
- 3 Eversão/inversão com elástico.** Sente, prenda um elástico no pé e empurre para fora e para dentro, controlado. Fortalece os estabilizadores laterais. 2–3 × 15.
- 4 Saltos e aterrissagens controladas.** Pulinhos no lugar e à frente, aterrissando macio e firme. Progrida para um pé só. 3 × 8–10.

POR QUE A PANTURRILHA É A ESTRELA

A panturrilha é o motor e o freio do tornozelo: ela impulsiona a cada passo e desacelera a cada aterrissagem. Panturrilhas fortes **protegem o tendão de Aquiles**, melhoram a corrida e estabilizam o tornozelo. Quase ninguém treina direito — comece você.

// 04 · EQUILIBRE

RECALIBRE OS **SENSORES**

É a frente com a melhor evidência para evitar a próxima entorse — e a mais simples. Tudo gira em torno de ficar em um pé só, progredindo o desafio.

A regra é progredir aos poucos: comece fácil e só avance quando dominar o nível anterior. Cada degrau "engana" os sensores um pouco mais, forçando-os a ficar mais rápidos e precisos.

- 1 Apoio em um pé, olhos abertos.** Segure 30 s firme por lado. Domina? Suba de nível.
- 2 Olhos fechados.** Tira a visão e força os sensores do tornozelo a trabalharem sozinhos. O salto de dificuldade é grande.
- 3 Superfície instável.** Em cima de uma almofada, travesseiro dobrado ou disco de equilíbrio.
- 4 Com perturbação / dinâmico.** Em um pé, passe uma bola de mão em mão, alcance objetos com o outro pé, ou faça mini-agachamentos unipodais.

A DOSE QUE FUNCIONA

5 minutos, quase todos os dias, vale mais que uma sessão longa de vez em quando. Escove os dentes em um pé só, espere o café em um pé só — encaixe na rotina e os sensores agradecem.

Já torceu o tornozelo e ele 'falha' às vezes? Isso tem reabilitação — me chama que eu monto o seu protocolo.

QUERO CUIDAR DA BASE

// ★ O PROGRAMA

A ROTINA DO TORNOZELO

Junte as quatro frentes numa rotina curta. 10–12 minutos, 3–4×/semana, é o suficiente para transformar a sua fundação em poucas semanas.

#	EXERCÍCIO	FRENTE	DOSES
1	Joelho à parede (mobilização)	Mobilidade	2×10/lado
2	Agachamento profundo (segura o fundo)	Mobilidade	2×30s
3	Panturrilha em um pé (excêntrica)	Força	3×8/lado
4	Eversão/inversão com elástico	Força/estab.	2×15
5	Apoio em um pé (olhos fechados)	Equilíbrio	3×20–30s
6	Aterrissagem em um pé	Estab./equil.	3×6/lado

COMO ENCAIXAR

Pode ser o **aquecimento** do seu treino de perna/corrida, ou uma rotina solta enquanto assiste TV (o equilíbrio, principalmente). Reteste o joelho à parede e o equilíbrio a cada 2 semanas para ver a evolução.

PROGRESSÃO

Aumente carga na panturrilha, suba o tempo/dificuldade do equilíbrio (olhos fechados → superfície instável) e a complexidade dos saltos. O corpo se adapta ao desafio — então o desafio precisa crescer.

// CAPÍTULO 06

APLICAÇÃO POR OBJETIVO

A base é a mesma, mas cada objetivo pede uma ênfase. Veja onde focar conforme o seu treino.

OBJETIVO	ÊNFASE NO TORNOZELO
Corrida	Panturrilha forte (impulsão e freio), mobilidade para a descida e equilíbrio para terrenos irregulares.
Musculação	Dorsiflexão para agachar fundo e seguro; panturrilha para o tendão de Aquiles.
Esporte de bola	Estabilidade e propriocepção (cortes e saltos); aterrissagens em um pé; eversão com elástico.
Pós-entorse	As quatro frentes, com prioridade total ao equilíbrio/propriocepção e retorno gradual.

APLICAÇÕES NO DIA A DIA

- ☐ **Antes de correr:** 2 min de mobilização de tornozelo + alguns saltos leves preparam a fundação.
- ☐ **No dia de perna:** use a rotina como aquecimento — agacha melhor e mais seguro.
- ☐ **Sempre que lembrar:** fique em um pé só. É "treino grátis" de equilíbrio que cabe em qualquer fila.

// CUIDADO

OS ERROS COM O TORNOZELO

Quatro hábitos mantêm a sua fundação fraca — e o ciclo de entorses e compensações girando.

- ☐ **Tratar a entorse como bobagem.** "Só torci, já passou." Sem reabilitar força, estabilidade e equilíbrio, ela vira problema crônico.
- ☐ **Só repousar a entorse.** Imobilizar e esperar não devolve a estabilidade. Movimento progressivo e propriocepção é que reabilitam.
- ☐ **Voltar cedo demais.** Sumiu a dor ≠ recuperado. Voltar ao esporte sem reabilitar é a receita da recidiva (e ela é alta).
- ☐ **Só alongar, nunca fortalecer.** Mobilidade sem força e controle é instabilidade. As quatro frentes andam juntas.

VOCÊ NÃO CUIDA DA CASA IGNORANDO A FUNDAÇÃO.

A BOA NOTÍCIA

Diferente de muita coisa no corpo, o tornozelo responde **rápido**: poucas semanas de mobilidade, força e equilíbrio já mudam a sua dorsiflexão, a sua estabilidade e a confiança a cada passo.

// A VIRADA

O QUE MUDA QUANDO A BASE FUNCIONA

Cuidar do tornozelo não é detalhe de fisioterapia — é o que destrava desempenho e protege tudo o que está acima dele.

-dor

JOELHOS E COSTAS

Tira a sobrecarga que sobe de um tornozelo travado ou instável.

+agach

TREINO MELHOR

Mais profundidade, mais segurança, mais força transferida.

-entorse

MAIS CONFIANÇA

Um tornozelo estável corre, salta e corta sem medo de torcer.

O detalhe é que o ponto fraco varia de pessoa para pessoa: um precisa de mobilidade, outro de estabilidade, outro de reabilitar uma entorse antiga. Avaliar e atacar **o elo certo** — na dose e na ordem certas — é o que transforma "fiz uns exercícios" em "minha base mudou".

O CAMINHO MAIS CURTO

Em vez de adivinhar, **avalie o seu tornozelo** e siga um programa sob medida — com progressão e reteste para provar a evolução da sua fundação.

// COMO EU POSSO TE AJUDAR

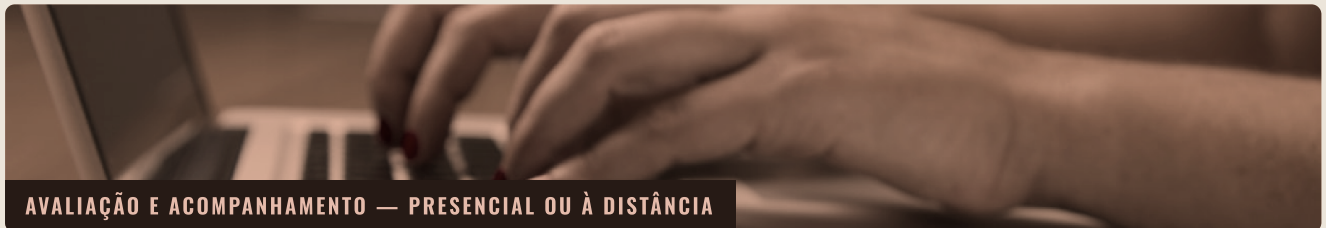
AVALIAÇÃO DE TORNOZELO

Eu avalio a sua fundação — mobilidade, força, estabilidade e equilíbrio — e monto um programa sob medida para blindar a sua base.

AVALIAÇÃO & PROGRAMA DE TORNOZELO

MOBILIDADE + FORÇA + ESTABILIDADE + PROPRIOCEPÇÃO

- ✓ **Avaliação completa** — dorsiflexão, equilíbrio, estabilidade e histórico de entorses.
- ✓ **Mapeamento do elo fraco** — descobrimos o que priorizar no seu caso.
- ✓ **Programa sob medida** das 4 frentes, calibrado ao seu objetivo e nível.
- ✓ **Reabilitação de entorse antiga** — quebrar o ciclo de recidivas, se for o caso.
- ✓ **Acompanhamento e reteste**, com suporte no WhatsApp.



AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO — PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA

QUERO CUIDAR DA BASE - WHATSAPP

// SEM COMPLICAÇÃO

COMO FUNCIONA

1

CONVERSA

Você me chama no WhatsApp e conta o seu caso e o seu objetivo.

2

AVALIAÇÃO

Testamos mobilidade, força, estabilidade e equilíbrio.

3

PROGRAMA

Você treina a sua base sob medida e a gente reavalia.

"TORCI O TORNOZELO FAZ TEMPO E ELE AINDA 'FALHA'. TEM JEITO?"

Tem, e bom. Instabilidade crônica responde muito bem a um programa de força e propriocepção. Quase nunca é tarde para reabilitar.

"NÃO TENHO DOR, PRECISO DISSO?"

Sim — é prevenção e desempenho. Melhorar a base reduz risco de entorse e dor de joelho, e melhora agachamento e corrida.

"NÃO SOU ATLETA, TREINO POR SAÚDE. SERVE?"

Especialmente. Equilíbrio e tornozelo forte são também sobre não cair e se manter ativo com o passar dos anos.

"FUNCIONA À DISTÂNCIA?"

Sim. Avaliação por vídeo, programa e acompanhamento online. Me chame para ver o seu caso.

Sente o tornozelo 'frouxo' ou trava ao agachar? Me chama — em uma conversa eu já te oriento o primeiro passo.

[QUERO CUIDAR DA BASE](#)

// POR QUE AGORA

TODA ENTORSE AUMENTA O RISCO DA PRÓXIMA

O tornozelo instável não melhora sozinho com o tempo — ele piora a cada torção ignorada. E cada compensação lá em cima vai se acumulando.

Quanto mais tempo a fundação fica fraca, mais o corpo se acostuma a compensar: o joelho desaba um pouco mais, a panturrilha enfraquece, os sensores ficam mais lentos. Cada entorse não reabilitada deixa o tornozelo mais frágil para a próxima — e ela vem mais fácil. O ciclo só quebra quando alguém decide cuidar da base de propósito.

Você já tem o mapa: entende a cadeia cinética, sabe testar a dorsiflexão e o equilíbrio, e tem o programa das quatro frentes. O que falta é aplicar com consistência e na dose certa para o seu caso — sobretudo se você já carrega uma entorse antiga. É a diferença entre conviver com um tornozelo que falha e ter uma base em que você confia.

A REAL

A fundação não pede muito: poucos minutos, com constância. Mas o retorno — menos dor, mais desempenho, menos lesão — paga juros altos por anos. **Comece a cuidar da base hoje.**

BASE FORTE SUSTENTA TUDO O QUE VEM EM CIMA.

COMEÇAR AGORA · FALAR NO WHATSAPP

CARTÃO DO TORNOZELO

TESTE (ANOTE OS DOIS LADOS)

- 1 **Joelho à parede:** alvo ~10 cm, calcanhar no chão.
- 2 **Um pé só, olhos fechados:** alvo ~10 s firme.
- 3 **Aterrissagem em um pé:** firme por 2–3 s.

A ROTINA (10–12 MIN · 3–4×/SEM)

FRENTE	FAÇA
Mobilize	Joelho à parede + agachamento profundo (segura o fundo)
Estabilize	Panturrilha 1 pé (excêntrica) + elástico eversão/inversão
Equilibre	1 pé só → olhos fechados → superfície instável
Aplique	Aterrissagens em 1 pé + saltos controlados

AS 3 REGRAS DE OURO

1. Mobilidade + força + equilíbrio andam juntos.
2. Reabilite toda entorse (parar de doer ≠ curar).
3. Pouco e diário > muito e raro.

// O PRÓXIMO PASSO

BLINDE A SUA FUNDAÇÃO.

Você tem o mapa da cadeia cinética, os testes e o programa das quatro frentes. Falta aplicar com consistência e na dose certa para o seu caso — em especial se há uma entorse antiga te seguindo. Eu avalio a sua base, monto o seu programa de tornozelo e acompanho a evolução, com reteste para provar o resultado.

AVALIAÇÃO & PROGRAMA DE TORNOZELO

Mobilidade + força + estabilidade + propriocepção, sob medida e acompanhado. A mesma ciência deste guia, aplicada a você.

AGENDAR AVALIAÇÃO NO WHATSAPP - (31) 9 9329-0622

WHATSAPP

(31) 9 9329-0622

INSTAGRAM

@preparadorfisico_gustavo

SITE

seuproximonivelestaqui.com.br

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS // QUALIS A1-A2

Herzog MM. et al. "Epidemiology of Ankle Sprains and Chronic Ankle Instability". Journal of Athletic Training, 2019 [A1]. · Doherty C. et al. "Recurrence and chronic ankle instability after lateral ankle sprain". Sports Medicine, 2014/2016 [A1]. · Schifftan GS. et al. "The effectiveness of proprioceptive training in preventing ankle sprains: a systematic review and meta-analysis". Journal of Science and Medicine in Sport, 2015 [A1]. · Estudos sobre dorsiflexão limitada e valgo de joelho no agachamento [A2]. Material educativo; não substitui avaliação profissional.